치과 치료 전, 골다공증 약을 어떻게 할까요

약을 스스로 끊지 마세요. 약 이름과 마지막 주사 날짜를 알려 주시면 치료 시점을 함께 정할 수 있습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치과 치료 전 세 가지를 기억하세요

필요한 치료는 미루지 말고, 약 조정은 담당 의사와 상의하세요.

1

필요한 치과 치료는 받습니다

스케일링·충치 치료·신경 치료는 약과 상관없이 받습니다. 곪은 이를 그대로 두는 쪽이 턱뼈에는 **더 나쁩니다**.

턱뼈 문제가 생긴 분들은 이미 곪은 이를 뽑은 경우가 많았습니다.

치과를 미루지 않기

2

약은 스스로 끊지 않습니다

먹는 약은 두세 달 쉬어도 뼈에서 빠지지 않고, 프롤리아는 늦어지면 **척추 골절**이 몰려옵니다. 조정은 내과에서 정합니다.

먹는 약은 중단 뒤에도 뼈에 남아 효과가 이어집니다.

끊기 전에 내과와 상의

3

약 이름과 마지막 주사 날짜를 알립니다

'골다공증약'이라는 말만으로는 치과가 판단할 수 없습니다. **약봉투나 처방전**을 그대로 보여 주시면 가장 정확합니다.

같은 '주사'라도 골다공증용과 암 치료용은 전혀 다릅니다.

약봉투 사진 한 장

실천 · 치과 예약이 잡히면 약 봉투와 마지막 주사 날짜를 내과·치과에 알려 주세요.

출처 · 마지막 장 아산 28회 연수강좌 — 최신 보험기준을 반영한 골다공증 진단과 치료 실전(김범준)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치과에서 어떤 치료를 받나요?

잇몸뼈를 건드리는 치료인지 먼저 확인하면 약 조정이 필요한지 판단할 수 있습니다.

약 조정 없이 받는 치료

뼈를 건드리지 않는 치료입니다. **평소처럼** 받으십시오.

- 스케일링·잇몸 관리
- 충치 치료·때우기
- 신경 치료(뿌리 치료)
- 틀니 조정 — 잇몸이 헐면 **바로** 고칩니다

VS

뼈를 건드리는 치료

못 하는 것이 아니라 **계획**이 필요합니다. 내과에 먼저 알려 주세요.

- 이 뽑기(발치)
- 임플란트
- 잇몸 뼈 수술·뼈 이식
- 먹는 약은 대개 그대로 · 프롤리아는 **주사 날짜**에 맞춰 계획

실천 · 치과에 발치처럼 잇몸뼈를 건드리는 치료인지 먼저 물어보세요.

출처 · 마지막 장

잇몸이 오래 아물지 않으면 알려 주세요

턱뼈가 드러나거나 상처가 계속 남는 드문 문제를 살펴야 합니다.

⚠ 세 가지가 모두 맞을 때

① 골다공증약이나 항암용 뼈 주사를 쓴 적이 있고 ② 턱뼈가 드러나거나 잇몸 구멍으로 뼈가 만져지는 상태가 **8주** 넘게 이어지고 ③ 턱 방사선 치료를 받은 적이 없을 때입니다.

드문 일입니다

골다공증 용량에서는 **드물게** 생깁니다. 암 치료용 고용량 주사를 맞는 분들에서는 훨씬 흔합니다.

이럴 때는 진료를 받으세요

뽑은 자리가 몇 주째 낫지 않거나, 이를 뽑지 않았어도 턱이 계속 아프고 뼈가 만져지면 치과 진료를 받으세요.



확인 · 상처가 8주 넘게 낫지 않거나 뼈가 보이면 치과에 알리세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약 이름과 치료 목적에 따라 위험이 다릅니다

골다공증 치료용과 암 치료용 주사는 위험의 크기가 다릅니다.

약	어떤 약인가	턱뼈 문제가 생기는 수	치과 치료 전에
약을 쓰지 않는 분	비교 기준	1만 명당 **0~2명**	—
먹는 골다공증약	알렌드로네이트 등 · 매주·매달 먹는 약	1만 명당 **2~5명**	대개 계속 드십니다 · 쉴지는 처방 의사가 정함
1년에 한 번 맞는 주사	졸레드론산 · 1년에 1회	1만 명당 **2명 이하**(자료마다 다름)	마지막 주사 날짜를 알리고, 시술 시점과 다음 주사를 함께 정함
프롤리아	6개월마다 맞는 주사	1만 명당 **4~30명**	마지막 주사 날짜로 시점 계획
암 치료용 뼈 주사	4주마다 · 골다공증 용량의 수십 배	**100명 중 1~15명**	암 담당 주치의와 먼저 상의

숫자 읽기 · 프롤리아 치료 중 발치한 분만 보면 427명 중 10명(2.3%)입니다. 치료받은 사람 전체의 위험과는 다릅니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

곪은 치아를 미루지 말고 치료하세요

입안 염증을 관리하고 치과 치료 계획을 함께 세우는 것이 중요합니다.

가장 흔한 계기는 발치

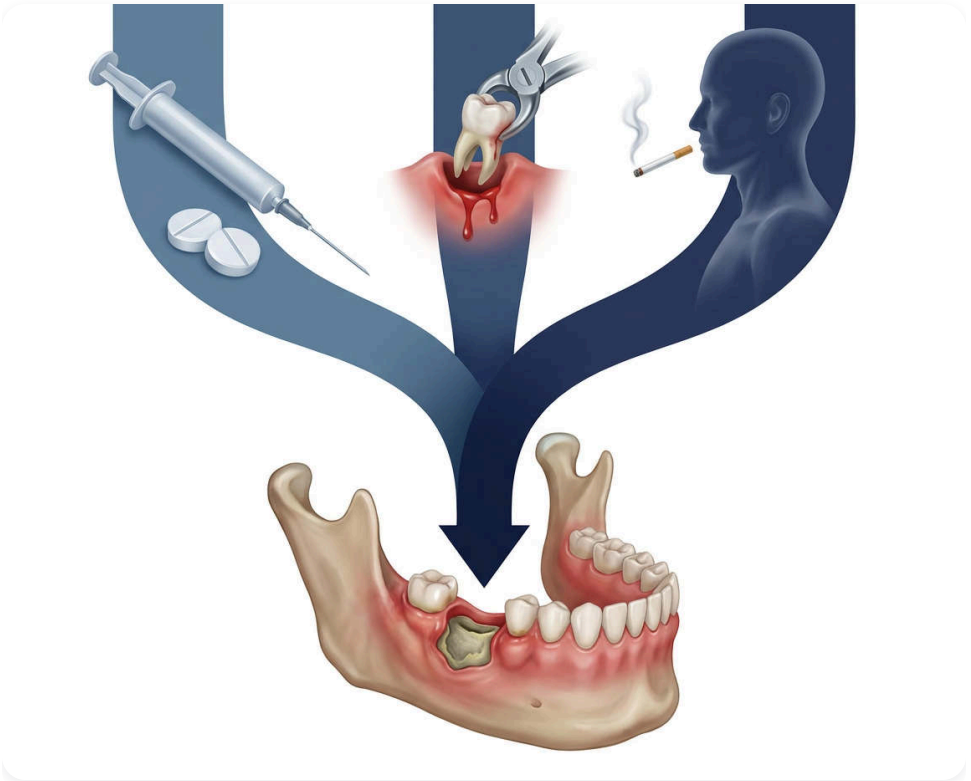
턱뼈 문제가 생긴 분들을 되짚어 보면 이를 뽑은 일이 앞선 경우가 가장 많았습니다. 다만 그 이가 **이미 곪아 있던** 탓도 큽니다.

입안에서 살펴볼 것

잇몸병(치주염) · 뿌리 끝 곪음 · 임플란트 주위 염증 · 잇몸을 계속 헐게 하는 안 맞는 틀니.

몸 쪽에서 겹치는 것

스테로이드를 오래 쓰는 경우, 당뇨, 콩팥병, 흡연, 고령이 겹치면 상처가 더디 아뭅니다.



실천 · 잇몸이 붓거나 치아가 곪았다면 약을 끊기 전에 치과와 처방 의사에게 알리세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

먹는 약과 6개월 주사는 다르게 계획합니다

약이 몸에 남는 시간이 달라 치과 치료 전 확인할 내용도 다릅니다.

먹는 골다공증약

뼈에 달라붙어 **수년 동안** 남습니다.

- 두세 달 쉬어도 뼈 안의 약은 그대로입니다
- 쉰 분과 계속 드신 분의 차이가 연구에서 확인되지 않았습니다
- 먹는 약은 중단 뒤에도 뼈에 남아 효과가 이어집니다
- **스스로 끊지 않습니다** — 오래 드셨거나 위험 요인이 있으면 쉴지 여부는 처방 의사와 치과가 함께 정합니다

vs

프롤리아(6개월 주사)

뼈에 쌓이지 않고 **몸에서 빠져나갑니다**.

- 주사가 늦어지면 뼈가 빠르게 약해지는 '반동'이 옵니다
- 반동은 척추 골절로 나타납니다 — 다음 장
- 그래서 치료 시점을 주사 날짜에 맞춥니다
- **끊지 말고 시점을 맞춥니다**

실천 · 약을 쉬라는 말을 들으면 먼저 약 이름과 마지막 투여 날짜를 두 의료진에게 알려 주세요.

출처 · 마지막 장 아산 28회 연수강좌 — 최신 보험기준을 반영한 골다공증 진단과 치료 실전(김범준)

프롤리아 다음 주사를 오래 미루지 마세요

주사를 중단하면 척추 골절이 늘 수 있어 다음 날짜를 함께 정해야 합니다.

숫자로 보면

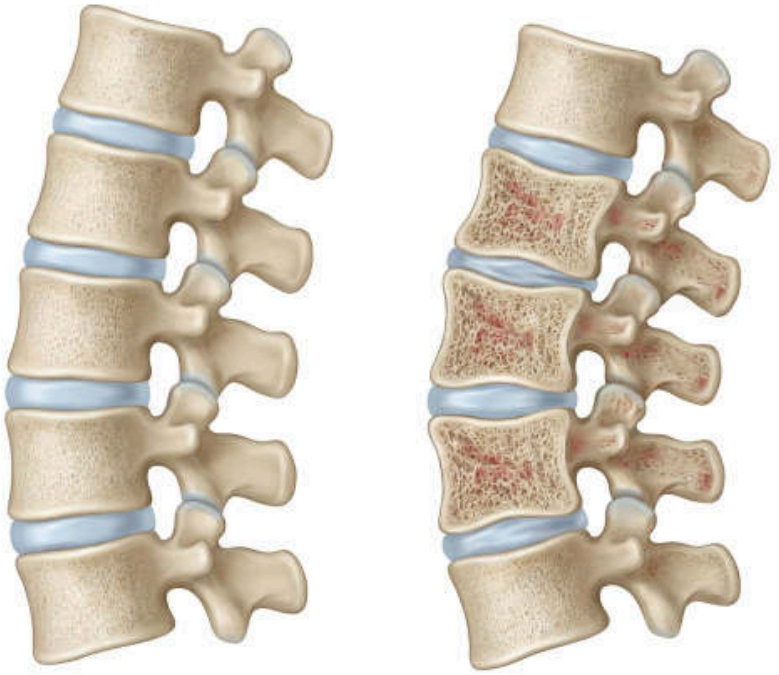
주사를 끊으면 척추 골절이 100명당 1년에 **1.2건에서 7.1건**으로 늘었습니다.

여러 마디가 함께

그때 생긴 척추 골절의 **61%**가 여러 마디였습니다. 키가 줄고 등이 굽기도 합니다.

특히 조심할 분

이미 척추 골절을 겪은 적이 있으면 여러 마디가 함께 무너질 위험이 **약 3.9배**였습니다.



실천 · 치과 치료 때문에 다음 주사를 미뤄야 한다면 처방 의사에게 먼저 연락하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

발치 날짜는 마지막 주사일을 보고 정합니다

프롤리아를 맞는 분은 마지막 주사 뒤 3~4개월 무렵을 의료진과 상의합니다.



주사 직후
주사 힘이 가장 셀 때

3~4개월 뒤
이를 뽑기 가장 무난한 때

너무 미루면
척추 골절 위험이 오르는 때

실천 · 마지막 주사 뒤 5개월이 지났다면 두 의료진에게 날짜를 확인하세요. 아프거나 곪았다면 바로 진료받으세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

프롤리아 주사와 치과 치료 일정을 맞춰요

마지막 주사일, 발치 예정일, 다음 주사일을 함께 확인합니다.

이럴 때	이렇게 합니다
계획해서 이를 뽑을 때	마지막 주사 뒤 **3~4개월**에 — 잘 아물고, 아직 반동이 올 시기는 아닙니다
마지막 주사가 5개월 넘게 지났을 때	더 기다리지 말고, 치과와 내과가 **발치 날짜와 다음 주사 날짜**를 함께 빨리 정합니다
많이 아프거나 곪았을 때	시점을 따지지 말고 **바로** 치료합니다 — 감염을 두는 쪽이 더 나쁩니다
이를 뽑은 뒤 다음 주사	**잇몸이 아물면**(보통 6~8주) 맞습니다 — 뼈가 다 찰 때까지 기다리지 않습니다
넘기지 말 선	6개월 정시가 목표 · **7개월**은 넘기지 않기 · 권고안의 마지막 한계선은 총 **9개월**

실천 · 다음 주사를 미루라는 안내를 받았다면 처방 의사에게 날짜를 꼭 확인하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

임플란트와 혈액검사, 무엇을 확인하나요?

임플란트 계획과 턱뼈 위험을 한 번의 검사 결과만으로 정할 수는 없습니다.

임플란트, 되나요?

대부분 가능합니다

골다공증 용량이라면 약을 끊지 않고도 심을 수 있다고 봅니다. 다만 위험이 얼마나 되는지는 아직 연구가 충분하지 않아, 치과와 처방 의사가 함께 판단합니다. 암 치료용 고용량 주사를 맞는 분은 이야기가 다릅니다.

시작 전 확인 잇몸병 · 당뇨 · 스테로이드 복용 여부 — 있으면 먼저 정리합니다

CTX 피검사로 안전한 날을 정하나요?

아니요 — 지금은 권하지 않습니다

뼈가 얼마나 활발히 바뀌는지 보는 피검사입니다. 예전에 이 수치로 발치 시점을 정하자는 제안이 있었지만, 맞히는 힘이 낮았습니다. 약 이름·마지막 주사일·입안 상태가 더 중요합니다.

34% 기준값 150으로 나눴을 때 턱뼈 문제가 생길 분을 미리 맞힌 비율

확인 · 임플란트 예정이라면 골다공증 약과 치과 치료 계획을 함께 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약마다 조정 기간과 재투약 계획이 다릅니다

강의에서 소개한 일정은 처방 의사·치과가 개인별로 적용합니다.

먹는 약·졸레드로네이트

- 김범준 연자는 경구 비스포스포네이트는 침습적 치료 전 **2개월 중단을 고려**한다고 설명했습니다.
- Q&A에서는 매주 먹는 제제도 같은 2개월을 적용한다고 답했습니다.
- 졸레드로네이트는 **6~12개월**의 간격을 소개했습니다.

vs

다시 시작할 때

- 약을 쉬는지와 시점은 골절 위험·치과 상태를 보고 **두 의료진이 함께** 정합니다.
- 김범준 연자는 Q&A에서 침습적 시술 뒤 **상피화가 완료되는 약 6~8주 후** 재투약이 원칙이라고 답했습니다.
- 데노수맙은 다음 주사를 무작정 미루지 않고 기존 일정표와 상처 회복을 함께 봅니다.

아산 28회 연수강좌 — 최신 보험기준을 반영한 골다공증 진단과 치료 실전(김범준)

치주염과 턱뼈괴사는 구분합니다

잇몸 문제는 치과에서 진단하고 골다공증 약은 처방 의사와 조정합니다.

김범준 연자 Q&A

- 김범준 연자는 Q&A에서 **치주염과 약물관련 턱뼈괴사(MRONJ)는 다른 진단**이라고 답했습니다.
- 잇몸이 아프다는 이유만으로 골다공증 약을 혼자 중단하지 않습니다.

vs

치과·내과에 함께 알리기

- 잇몸이나 임플란트 주위 염증이 생기면 먼저 **치과 진료**를 받습니다.
- 약 이름·마지막 주사일을 보여 주고 진단과 치료·약 조정을 함께 정합니다.
- 데노수맙을 마무리할 때는 비스포스포네이트로 이어가는 계획이 중요합니다.

아산 28회 연수강좌 — 최신 보험기준을 반영한 골다공증 진단과 치료 실전(김범준)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치과에 이 네 가지를 알려 주세요

약 이름·치료 목적·마지막 투여일·예정된 치과 치료를 함께 알려 주세요.

① 약 이름

'골다공증약'이라고만 하지 마시고 정확한 이름을 알려 주세요. 약봉투나 처방전을 그대로 보여 주시면 정확합니다.

② 마지막 주사 날짜

프롤리아처럼 6개월마다 맞는 주사는 마지막 날짜가 계획의 출발점입니다. 날짜를 달력이나 휴대폰에 적어 두세요.

③ 얼마나 오래 썼는지

언제부터 얼마나 오래 쓰셨는지, 중간에 바꾼 약이 있는지도 함께 알려 주세요.

④ 골다공증용인지, 암 치료용인지

'주사 맞아요'만으로는 구분되지 않습니다. 암 치료로 맞는 뼈 주사라면 꼭 말씀해 주세요.

실천 · 약봉투를 휴대폰으로 찍어 두면 치과에서 바로 보여 줄 수 있습니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

골다공증 치료 중 치과 치료를 앞둔 분들을 위한 설명자료입니다. 실제 치료 시점과 약 조정은 담당 의사·치과와 상의해 정합니다.

참고한 자료

AAOMS 2022 권고안 · 한국 권고안 2025 · Cummings 2018 · Colella 2023 · Kim 2024 · Lyu 2020 · 휴약 메타분석(8편) · JADA 메타분석

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다